ВЫПИСНОЙ ЭПИКРИЗ

Отделение: психиатрическое (общее) № 3
Пациентка Н., 46 лет. Находилась на стационарном лечении 23 дня.

Жалобы при поступлении

Подавленное настроение, утрата интереса ко всему, бессонница с ранними пробуждениями в 4–5 утра, снижение аппетита (похудела на 6 кг за 2 месяца), мысли о бессмысленности жизни.

Анамнез заболевания

Первый депрессивный эпизод в 31 год после смерти отца, лечилась амбулаторно, ремиссия. Второй эпизод в 39 лет. В 2019 г. — суицидальная попытка (отравление лекарствами), госпитализация в токсикологию. Настоящее ухудшение около 3 месяцев, без явного повода. Амбулаторно принимала сертралин 100 мг в сутки в течение 8 недель — без эффекта.

Анамнез жизни

Замужем, двое детей. Работает бухгалтером. Мать страдала депрессией. Алкоголь не употребляет.

Психический статус при поступлении

Гипомимична, речь тихая, замедленная. Настроение резко снижено. Высказывает идеи малоценности. Суицидальные мысли без плана, критика частичная.

Диагноз

F33.2 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод тяжёлой степени без психотических симптомов.

Проведённое лечение

Сертралин отменён. Назначен венлафаксин с титрацией до 75 мг 3 раза в день, кветиапин 50 мг на ночь. На фоне лечения настроение выровнялось, сон восстановился, суицидальных мыслей не высказывает.

Рекомендации

Продолжить венлафаксин 75 мг 3 раза в день, кветиапин 50 мг на ночь. Наблюдение психиатра ПНД через неделю после выписки.